

Gravidez ectópica · diagnóstico e conduta

Ectópica = implantação fora do endométrio uterino (maioria tubária). Dor + sangramento + βhCG positivo exigem excluir ectópica; instabilidade = cirurgia.

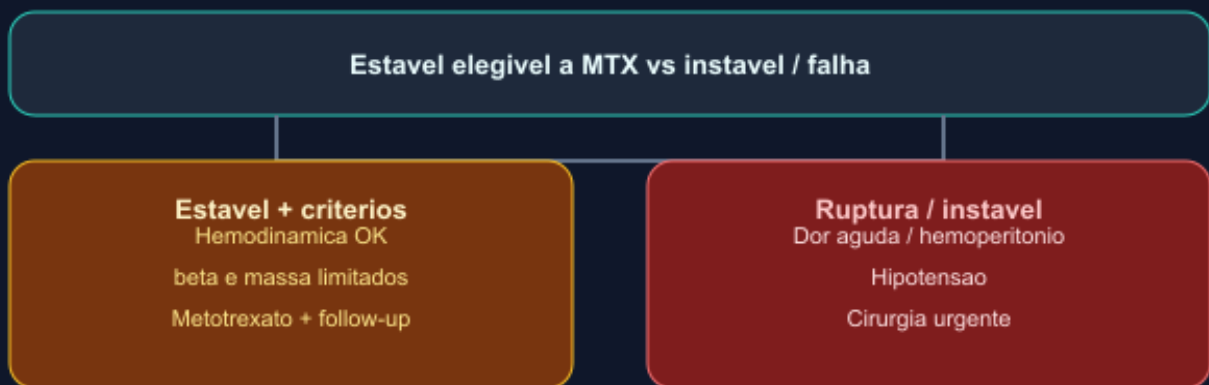
Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

USG transvaginal: útero vazio com βhCG elevado F&T iminatório + massa anexial/líquido sugere ectópica. Discriminação: acompanhar curva de βhCG

Ramificação: estável com critérios ! metotrexato; ruptura/instabilidade ! laparoscopia/laparotomia.

Gestacao ectopica



Metotrexato — ideia de elegibilidade

- Estabilidade hemodinâmica e adesão ao seguimento
- βhCG muito elevado (cortes variam; banca cita limites clássicos)
- Sem ruptura, sem contraindicação hepático-renal/hematológica
- Seguimento obrigatório do βhCG

Conduta cirúrgica

Situação | Opção

Estável, desejo reprodutivo | Salpingostomia selecionada

Tubária destruída / sangramento | Salpingectomy

Instável | Via mais rápida disponível

Dúvida diagnóstica | Laparoscopia diagnóstica

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

βhCG 'em queda' não exclui ruptura iminente. Dor aguda + sinais peritoneais em mulher em idade fértil = protocolo de ectópica/hemoperitônio, não alta com analgésico.